

Spirituaalsus kui ressurss inimeste taastumisel ja rehabilitatsioonis

Indrek Linnuste

Artikkel tõstab praktilise sotsiaaltöö konteksti seni kasutamata ressurssina spirituaalsuse ehk elu tähenduse, eesmärgi, tõe ja väärtustega seotud inimkogemuse mõõtmise. Viimastel aastakümnetel on toimunud mitmeid muutusi nii tervishoius kui hoolekandes, mille kokkuvõttena saab öelda, et 21. sajandi rehabilitatsiooni juhtivaks põhimõtteks on saanud inimesest lähtumine. Spirituaalsus võib olla just see vahelüli, mis seob taastumisteenustel oleva kliendi „suurema pildiga” ja „minapildiga”. On mitmeid tõendeid, et spirituaalse toe integreerimine vaimse tervise teenuste ja taastumisele suunatud mudelitega on võimalik ja tõhus, kuid see nõuab spetsialistidelt vastavaid teadmisi, oskusi ja hoiakuid.

Sissejuhatus

Käesoleva artikli eesmärk on juhtida sotsiaalvaldkonnas tegutsevate spetsialistide tähelepanu spirituaalsusele kui Eestis seni alakasutatud ressurssile eeskätt psüühikahäiretega inimeste taastumises ja laiemalt rehabilitatsioonis. Sotsiaaltöötajad ja tegevusjuhendajad puutuvad klienditöös kokku mitmesuguseid kriise ja keerulisi eluolukordi kogeivate inimestega. Inimestel võib olla mitmesuguseid uskumusi iseenda, ümbritseva maailma ja elu eri tahkude kohta, mis toetavad nende eluga hakkama saamist või vastupidi, võivad seda olulisel määral takistada. Mis võiks olla spetsialisti vastutus spirituaalsust puudutavate teemade käsitlemisel ning kas seda vastustust saab kliendiga jagada? Kas spetsialist peaks üritama muuta klienditöö käigus kogu kliendi kognitiivset süsteemi ehk seda, kuidas inimene teadvustab oma olukorda, tervises seisundit ja edasist taastumist, või võiks

ta pigem toetada kliendis sisemist äratust ja motivatsiooni oma taastumisteenustele asumiseks ning jääda ise kaasteeliseks?

Spirituaalsus on universaalne inimkogemuse mõõde, mis on seotud elu tähenduse, eesmärgi, tõe ja väärtustega. See võib, aga ei pruugi olla seotud religiooniga, sõltudes nii inimese sisemisest teadlikkusest kui ka kogukonna, sotsiaalsete gruppide ja traditsioonide mõjust. (Cooke 2014).

Spirituaalsed ja religioossed teemad on olnud läbi ajaloo lahutamatu seotud hoolekande ning tervishoiuga. Kuigi need distsipliinid kasvasid valgustusaja järel kiiresti lahku, on eelmise sajandi lõpus ja 21. sajandil taas hakatud otsima kokkupuutepunkte, mida kinnitavad nii mitmed teaduslikud võrgustikud¹, instituudid² kui teemat käsitlevate teadusartiklite arvu kiire kasv.³ Antakse välja ka spetsialistidele mõeldud käsiraamatuid, artiklite kogumikke ja muud erialast kirjandust, mis annab juhtnööre

spirituaalsusega seotud teemadel.⁴

Nüüdisaegses ühiskonnas on paljud inimesed väga haavatavad, kuna nad peavad hakkama saama oma individuaalse erivajaduse või tervise probleemidega ning teisalt kohanema muutustega ühiskonnas ja hoolekande korralduses ning pakutavates teenustes, nagu näiteks Eestis on seda käimasolev töövõime- ja erihoolekande reform. Nõudlus vaimse tervise teenuste järele on kasvamas, samas ka ühiskonna ootused osutatava abi kvaliteedi suhtes. See paneb otsima vaimse tervise valdkonnas uusi, seni kasutamata toetamise viise, mis lähtuksid inimesest ja tema vajadustest, sh nt üleminek kogukonnapõhistele teenustele (Tsuiman 2016), koosloome või teenuste disain (Uibu 2018). Tervishoius on taandumas arstide domineerimine, hierarhiat asendavad integreeritud ravimeeskonnad ning palju räägitakse holistilisest ehk teraviklikust tervisekäsitusest.

Üheks tunnustatud suunaks vaimses tervises on saanud taastumiskeskne mõtteviis, kus taastumise all mõistetakse isiklikku protsessi, mille käigus inimene saavutab uuesti enesekindluse, õpib paremini toime tulema oma haavatavusega ja hakkab taas täitma sotsiaalseid rolle (Wilken ja Hollander 2015). Spirituaalsuse kaasamine kliendi taastumisteedekonnal või vähemalt

selle mittevälistamine aitab muuta rehabilitatsiooni- ja ravimeeskondi integreeritumaks ja laiahaardelisemaks, et need saaksid toimida sõna otseses mõttes terapeutiliselt.⁵ Spirituaalsuse kui ressursi tunnustamine sotsiaalvaldkonna spetsialistide poolt võiks olla abiks ka sallivuse aspektist lähtudes, sest universaalsed elujaatavad väärtushinnangud kuuluvad lahutamatu sotsiaalsete elukutsete alusprintsipiide hulka.

Artikkel annab esmase sissejuhatuse spirituaalsusega seotud teemadesse, tutvustades spirituaalsuse mõistet ja spirituaalsuse kohta taastumiskeskse mõtteviisi, samuti eri autorite seisukohti selle suhtes, mis kasu on spirituaalsuse kasutamisest tervishoius ja hoolekandes. Tuuakse välja ka mõned lihtsamad meetodid, mille abil hinnata inimeste spirituaalseid vajadusi ning võimalusi spirituaalse toetuse loomimiseks vaimse tervise teenuste kasutajate taastumisse. Teemade üldistav käsitlus on ajendatud soovist mitte minna liiga spetsiifiliseks, vaid pigem aidata lugejal teadvustada, et spirituaalsusele pääseb iga inimene ligi ja seda on võimalik endas ja enda ümber ära tunda ja kasvatada ning selle juurde ka teisi juhatada.

Kuigi artikkel keskendub spirituaalsuse kaasamisele psüühilise erivajadusega klientide taastumisel ja

¹ Näiteks The Spirituality and Psychiatry Special Interest Group, www.rcpsych.ac.uk/members/specialinterestgroups/spirituality.aspx.

² Näiteks European Network of Research on Religion, Spirituality and Health, <http://www.rish.ch/en/home>.

³ Kuni 2010. aastani ilmus rahvusvahelistes teadusajakirjades 50–200 erinevaid spirituaalseid praktikaid käsitlevat eelretsenseeritud artiklit aastas, 2014. aastal käsitleti meditatsiooni juba 394s, joogat 412s ja *mindfulnessi* ehk teadvelolekut 773s eelretsenseeritud artiklis (*Contemplative mind in life* 2014)

⁴ Üheks heaks näiteks on Jo Barberi ja tema kolleegide (2009, 2015) käsiraamat *Handbook of spiritual care in mental illness*.

⁵ Sõna *teraapia* juur on ladina ja kreeka keeles, ld *therapia*, kr *therapeia*; ingl k vasteid: *curing, healing, service done to the sick; a waiting on, service*, www.etymonline.com/index.php?term=therapy&allowed_in_frame=0.

rehabilitatsiooniprogrammides, ei ole inimest võimalik jagada distsipliinide ja institutsioonide vahel, seega puudutab teema ning selle lähtekohad kõiki eluvaldkondi, inimesi ja kogukondi.⁶

Spirituaalsus

Mis on spirituaalsus ja kas või kuidas on see seotud religiooniga? Kui otsetõlkena eesti keelde kasutada spirituaalsuse asemel sõna vaimsus, siis võib see mõiste jääda liialt laialivalguvaks seostudes pigem vaimse, vaimuvara, mõistuse, meele jms teemadega, teisalt on spirituaalsus kui mõiste küllalt hästi sulandunud eesti keelde ja kultuuri⁷. Spirituaalsust saab defineerida olenevalt sellest, kas fookuses on teaduslik uurimistöö või praktiline väljund (Koenig 2008). Esimesel juhul on oluline täpsus, millele

rajatakse uurimistöö struktuur, samas praktilises töös on määratluse keskmes pigem indiviid oma individuaalsete spirituaalsete vajadustega, mis on igaühele subjektiivselt ainuomased. Näiteks jättis professor David Hay oma uurimistöös spirituaalsuse teadlikult defineerimata, et avastada inimeste personaalne arusaam oma individuaalsest spirituaalsusest. Hay sõnul on iga inimene spirituaalne, pigem keskenduti uurimuses osalejate maailmapildile ja elukogemusele. Spirituaalne lugu või narratiiv on iseenesest palju võimsam, kui mistahes kirja pandud definitsioon. (Hay ja Hunt 2000)

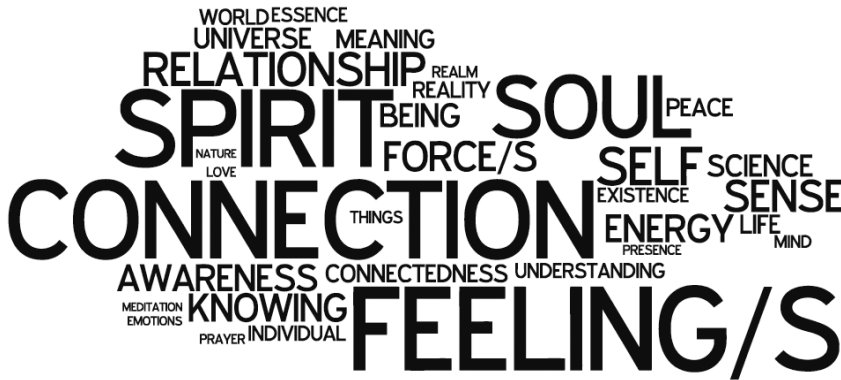
Et spirituaalsuse mõistet täpsustada ja eristada religioonist, millega seda sageli samastatakse, on joonistel 1 ja 2 välja toodud Stefan Altmeyeri ja Constantin Kleini (2016) korpusanalüüsi tulemused



Joonis 1. Võtmesõnade pilv (nimisõnad, $n \geq 5$, $p \leq 0,0025$) religiooni kohta, vastandatuna spirituaalsusele (tekstikorpus) USA näitel. (Klein ja Altmeyer 2016)

⁶ Töötan ise nii meditsiinisüsteemis kui ka sotsiaalteenuseid pakkuvast sotsiaalses ettevõttes, mis lähtub maailmas üha enam levinud spirituaalse ettevõtluse põhimõtetest.

⁷ Religioonisotsioloogia käsitleb spirituaalsust ja sellega seonduvat pigem nn uue vaimsuse kontekstis. Vaatamata vaimsuse mõiste laiale ning väga erinevaid tähendusi hõlmavale tähendusväljale, tuntakse uue vaimsusega seonduvat siiski üldiselt ära ning suudetakse seda eristuva nähtusena käsitleda. (Altnurme 2013)



Joonis 2. Vötmesõnade pilv (nimisõnad, $n \geq 5$, $p \leq 0,0025$) spirituaalsuse kohta, vastandatuna religioonile (tekstikorpus) USA näitel. (Klein ja Altmeyer 2016)

Tabel 1. Lihtsustatud tabel vötmesõnadest (Saad ja Mereiros 2012).

Religioon	Spirituaalsus
Konkreetsed uskumused ja tavad, liturgia	Sisemise rahu ja seotuse tunne
Kultuuriga tihedalt seotud	Universaalne isikuomadus
Kogukonda ühendav (väljast sisse)	Individuaalne (seest välja)
Jälgitav, mõõdetav, objektiivne	Ei ole nii jälgitav-mõõdetav, subjektiivne
Organiseeritud, ortodoksne, formaalne	Ei ole eriti organiseeritud
Traditsiooniline	Sünkretistlik, kombineeritud
Autoritaarne	Emotsionaalne, sissepoole suunatud
Eksogeenne ehk välistekkeline	Endogeenne ehk sisetekkeline
Vastutav	Ei ole nii rangelt vastutav

lingvistilises pilves.⁸ Tulemused näitavad, et „religiooni” puudutav keelekasutus on ülekaalukalt objektiivne-materiaalne („reeglid”, „usk”, „rituaalid”, „kirik”, „süsteem”, „kogukond” jne). Kuigi ka „spirituaalsuse” puhul on objektiivne-materiaalne mõõde enim esindatud, on selle puhul oluline

subjektiivne faktor („vaim”, „ühendus/ühendus”, „hing”, „täendus”).

Tabelile 1 tuginedes näeme, et religioonil ning spirituaalsusel on erinevad omadused, mis aga ei sega, vaid pigem täiendavad teineteist. Tanyi (2002) analüüsis oma uurimistöös spirituaalsuse mõiste selgitamiseks

⁸ Joonised on koostatud autorite uuringute põhjal. Käesoleva artikli kontekstis toovad need esile lihtsad infopilved mõistete tähendusväljadest, kuidas „religiooni” ja „spirituaalsust” erinevalt tajutakse. Korpusanalüüsi kasutamine mõistete uurimisel võimaldab tuvastada erinevusi küsitletavate sõnavaras. Otsitakse põhisõnu, mis iseloomustavad tekstide sisu ja stiili.

76 artiklit ja 19 teemakohast raamatut ning jõudis järeldusele, et spirituaalsus on inimeseks olemisele omane nähtus, mis on subjektiivne, raskesti taibatav ja mitmemõõtmeline. Spirituaalsus hõlmab elu tähenduse otsinguid, samas kui religioon sisaldab organiseeritud üksust rituaalide ja tavade, mis on suunatud kõrgemale jõule või Jumalale. Seevastu võib spirituaalsus mõnede indiviidide jaoks küll olla seotud religiooniga, aga teiste jaoks, näiteks ateisti puhul mitte. Tanyi (2002) kokkuvõttest järeldub, et spirituaalsus kujuneb elu tähenduse ja mõtte personaalse otsingu käigus, mis võib, aga ei pea olema seotud religiooniga. See võib olla näiteks kedagi abistades enda kasulikkuse tunnetamine, kuuluvustunde kogemine, eneseleidmine kunsti või huvitegevuse kaudu, oma kultuurilise identiteedi teadvustamine ehk kõik see, mis aitab luua ühenduse oma veendumuste ja/või religioossete uskumuste, väärtushinnangute ja tavade, mis annavad elule tähenduse, seeläbi inspireerides ja motiveerides inimest saavutama oma parimat olemust. See ühendus sisendab usku, lootust, rahu ja mõjuvõimu. Tulemuseks on rõõm, endale ja teistele andestamine, raskuste ja enda surelikkuse teadvustamine ja aktsepteerimine, kõrgendatud tunnetus füüsilisest ja emotsionaalsest heolust ning võime ületada eksistentsiaalseid kriise. Käesolevas artiklis vaadeldakse religioosseid, spirituaalseid ja isiklikke uskumusi koos: spirituaalsust nähakse sisemise ning religiooni välise ressursina.

Spirituaalsust ei ole võimalik kellelegi peale suruda, see on immanentne, st inimesele seesmiselt omane kvaliteet, mis on

indiviidile ainuomane ja kõnetab teda koos pühaduse mõistega. Kuid spirituaalsust on võimalik indiviidis ka äratada, kasutada seda kui ressursi, mida teadlikult inimese heaks tööle rakendatakse.

Positiivse spirituaalsuse kõrval on oluline ära tunda ka inimese vaimsele tervisele ja heolule kahjulikult mõjuvaid uskumusi, mis panevad inimest tundma ennast õnnetuna ja väärtusetuna või tekitavad soovi kahjustada ennast või teisi. Näiteks võib inimene usulistel põhjustel keelduda ravist või uskuda, et mingi kõrgem jõud paneb teda sooritama ebaratsionaalseid tegusid. Ka sellistel juhtudel saab inimese abistamiseks kasutada muuhulgas spirituaalsust kui ressursi. (Barber jt 2009, 2015).

Lähtumine inimesest ja taastumine

21. sajandi tervishoiu ja hoolekande juhtivaks põhimõtteks on saamas lähtumine inimesest. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) avaldas 2015. aastal ülemaailmse inimesekesksete ja integreeritud tervishoiuteenuste strateegia. Hoolekandes on võetud kasutusele mitmed kasutaja vaatenurgast lähtuvad teenuste kvaliteedi standardid, nagu näiteks EQUASS⁹. Haiglatesse ja hoolekandetasutustesse on tööle võetud kvaliteedispetsialistid, kelle üheks ülesandeks on muuta teenused läbipaistvamaks ja selgemaks nii teenust vajavatele inimestele kui nende omastele. Lisaks tervisele ja toimetulekule on tähelepanu suunatud elukvaliteedile ja heolule. Elukvaliteedi ühe aspektina on WHO välja toonud ka spirituaalse mõtme.¹⁰

Oluliseks peetakse partnerlust teenuse

⁹ EQUASS on Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimise süsteem <http://www.equass.ee>.

¹⁰ WHO on elukvaliteedi mõõtmiseks loodud testis üheks aladomeeniks võtnud inimese spirituaalsuse ja isiklikud uskumused http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf.

osutaja ja teenuse saaja vahel. Universaalset lahendust kõigile olukordadele ei ole ega saagi olla, sest iga inimese vajadused on individuaalsed. Seetõttu tuleb jagada vastutust töö tulemuste eest spetsialistide/institutsioonide ja inimese vahel. Selle juurde käib inimestele oluliste teemade selgitamine ja nende teadlikkuse tõstmine, et nad saaksid olla võrdsed partnerid ressursside jaotamisel ning neist kasusaamisel. Hoolekandes pakub selleks häid võimalusi suund taastumismudelite üha laiemale kasutamisele.

Erinevalt kliinilisest taastumisest, mis on seotud traditsioonilise meditsiinilise mõtteraamistikuga, saab personaalne taastumine alguse kogemuspõhisest teadmisest (Slade 2009). Taastumisliikumine tekkis protestiks pakutavate vaimse tervise teenuste ja meditsiinilise toimimise paternaliseeriva, st haigestunu elu kõiki aspekte kontrolliva hoiaku tõttu (Drake ja Whitley 2014). Taastumise puhul on võtmeroll taastujal endal: see on arenemise ja identiteedi taasloomise protsess, kus tuleb omandada oskused haavatavusega toimetulekuks, võtta oma elu ja heaolu eest vastutus ja püüda võimalikult suurt eneseväärikust säilitava autonoomia, eakohaste rollide ja kodanikuõiguste poole (Wilken ja Hollander 2015).

Vaimse tervise taastumise uuringute puhul on mitmete toetamist vajavate komponentide või eluvaldkondade hulgas – kogukonda integreeritus, peresuhted, elamispinna korraldus, haiguse sümptomite kontrollimine, optimism, turvalisus, sotsiaalsed võrgustikud, toetavad sõprussuhted – välja toodud ka spirituaalsus (Davidson jt 2001, viidanud Drake ja Whitley 2014). Peamised eeldused taastumiseks on lootus, võime võtta vastutus oma isikliku taastumise eest, mõtestada enda jaoks elu tähendus ning oma identiteet (Slade 2009).

Identiteedi saavutamiseks on vaja jõuda mõtestatud looni, mis seob elu tervikuks. Taastumislood on erinevad, kuid neil on ühiseid jooni: elule uue mõtte leidmiseks on inimesel vaja turvalises keskkonnas rääkida ja läbi töötada oma elulugu. See nõuab oma eluloos probleemidele ja elusündmustele tähenduse ja isikliku loogika leidmist, alles seejärel saab haigusest ja kannatustest kaugele vaadata. (Wilken ja Hollander 2015, 25; Hietala-Paalasmaa jt 2006).

Erihoolekandes populaarsust kogunud Dirk den Hollanderi ja Jean-Pierre Wilkeni rehabilitatsioonikäsitlust sisaldav raamat „Kuidas klientidest saavad kodanikud” (2015) on üles ehitatud just taastumisprotsessile ning stigmade murdmisele. Alljärgnevalt esitatakse nende autorite mõttekäigud (lk 86) taastumise kohta, mis hästi haakuvad spirituaalse toe põhimõtetega.

On inimesi, kes on psüühikahäiretest taastumist hakanud nimetama spirituaalseks teekonnaks. Inglise keeles on sõnademängus *path* ja *pathology* võimalik muuta vaatenurka, kus haigust nähakse kogemusena, mis läbituntuna avab ja juhatab meid enda tundmaõppimise teekonnale, ajendades esitama suuri küsimusi, nagu miks see haigus või olukord on just mulle osaks saanud? Mis on minu koht maailmas? Sellised küsimused aitavad suurendada haigusteadlikkust.

Kui inimene muutub julgeks, ei karda avada oma lugu, siis on oma kogemuste jagamine üks paremaid teid tervenemise poole. Eestiski on kogemusnõustamise teenus hoogu võtnud (Sotsiaalministeerium 2014). CARE metoodika juhendis (*s.a*) on spirituaalsus ja elu mõtestamine kliendi profiilis eraldi välja toodud, seda saab ressurssina koos lootuse ja usuga kasutada ühe taastumistöö motivaatorina (Wilken 2013).

Taastumine Dirk den Hollanderi ja Jean-Pierre Wilkeni käsitus (2015)

- Taastumise all mõistame seda, et pärast (tervet rida) traumaatilisi kogemusi hakkab inimene taas oma elu elama ja leiab sellele uuesti mõtte. Üldisemas mõttes on siin tegemist kasvamis- ja arengemisprotsessidega. (24)
- Taastumise all mõistame esmajoones „tervenemise” individuaalset kulgu: haigusega ja/või puuetega elama õppimist. Aga ka toimetulekut nende tagajärgedega: häbimärgistamisega, mida – nii küüniline kui see ka ei ole – tuleb ette tugiteenuse osutajate poolt, nagu ka soovitusi vältida erutumist ja stressi ehk teisisõnu soovitatakse elada tuima, ükskõikset elu. Stress, pinged ja probleemid kuuluvad juba kord tõelise elu juurde ka siis, kui sul on skisofreenia või autism. (26)
- Taastumisprotsess on seotud **minapildi** ja **elu mõtte taasleidmisega**. Oluline on loobumine „vanast minapildist”, mida tihti tugevalt mõjutab kliendi/patsiendi rolli. (26)
- Taastumisprotsessid on täpselt sama erinevad nagu ka inimesed, kes selle läbi teevad. Taastumiseni viib palju teid ja nende ainus ühisomadus on see, et ükski neist ei kulge sirgelt soovitud sihis. Elu mõtte ja enesekuvandi taasleidmise puhul on tegemist ainulaadse protsessiga. (27)
- Tõenäoliselt on tegemist kõige tähtsama vaimse tervise teenuste trendiga üldse. Taastumiskeskne mõtteviis koondab arvukalt erinevaid ideid (võimestamine, enesejuhtimine, puuetega inimeste õigused, sotsiaalne kaasamine ja rehabilitatsioon) ühe lipu alla, mis annab märku uuest suundumusest vaimse tervise teenustes. (206)
- Ravi ning enda ja oma haiguse mõistmine käivad taastumisega käsikäes; aktiivne ravi võib moodustada taastumises tähtsa osa, siin ei teki mingit vastuolu. „Enese mõistmine” on väga pretensioonikas väljend. Siin ei ole tegemist „kõik-või-mitte-midagi” olukorraga ning mitte kellelgi ei ole selle üle ainuotsustusõigust. Tähtsam kui enese olukorra mõistmine on see, kuidas inimene oma elu erinevaid aspekte hindab. (206)

Spirituaalsuse kasutamise kasutegurid

Nagu ütleb psühholoog Kenneth Pargament (2007), ei jäta inimene terapeudi juurde tulles oma spirituaalsust ooteruumi. Me oleme rohkemat kui psühholoogilised, sotsiaalsed ja füüsilised olendid, me oleme ka spirituaalsed. Paljudele inimestele on suhte omamine kõrgema jõuga nende psühholoogilise heaolu alustala. Spirituaalse toe pakkumine tähendab, et toetatakse inimeses tunnet, et ta on ühenduses kõrgema jõuga, mis aktiivselt, kaitseb, juhendab, õpetab, aitab ja ravib. Spirituaalsus on oluline toimetuleku mehhanism, kuna inimesed, kui nad kogevad raskeid haigusi, otsivad neile tähendusi.

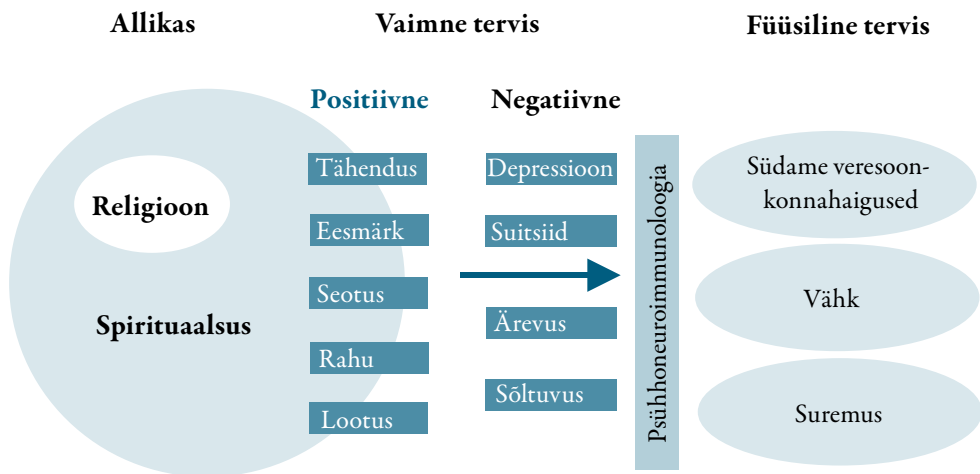
Spirituaalsus võib olla vahelüli, mis seob taastumisteenekonnal oleva kliendi „suurema pildiga” ja „minapildiga”. See seab kesksiks väärtuseks inimese individuaalsuse, ainulaadsuse, samas unustamata seotust transtsendentaalsete ehk *mina* piire ületavate väärtustega. Lukoff (2007) julgeb väita, et spirituaalsuse kaasamine eristab personaalset taastumist varasematest vaimse tervise mudelitest: see lisab väljavaate, et inimene võib täielikult paraneda isegi väga raskekujulisest psüühikahäirest. Juba oma olemuselt on spirituaalsus seotud elujõu, motivatsiooni ja positiivsete väärtuste ja suunaga tervisekäitumises (Culliford ja Eager 2009).

Spirituaalsust ei saa peale suruda või seda intellektuaalsel tasandil õpetada, pigem sobib seda põimida nõustamisprotsessiga ja suunata sel viisil inimese tähelepanu tema siseelule. Kaasaegses ühiskonnas pommitab välisilm inimesi infomüraga ning meie tähelepanu on suunatud väliskeskkonnale. Sellega võideldes, rolle ja maske kandes kaotab inimene jõu, mida tal tegelikult on vaja haigusest taastumiseks. Sisemised ja välimised ressursid peavad tasakaalus olema. Culliford (2016) Briti Kuninglikust Psühhiaatria Seltsist mainib spirituaalset juhendamist (*coaching, leadership*) kui üht võimalust arendada klientides võimet märgata omi sisemisi ressursse ja omistada oma elule tähendus. Populaarse emotsionaalse intelligentsuse teema kõrval räägitakse järjest enam spirituaalsest intelligentsusest SQ (Wigglesworth 2014). Culliford (2002, 255) esitab kokkuvõtlikult olulisemad spirituaalsuse integreerimise tulemused

klientide taastumisse:

- ♦ parem enesekontroll, enesehinnang ja enesekindlus
- ♦ aitab suurendada isiklikku võimekust
- ♦ oluline tugi leina ja kriisist taastumisega toimetulekul
- ♦ kindlamad suhted iseenda, teiste ja jumalaga (kõrgema väega)
- ♦ tähenduste tunnetus, mis annab uut lootust ja meelerahu, et ära leppida oma elu probleemidega ning mitte sipelda eneschaletsuse ja enesesüüdistuste võrgus.

Harold G. Koenig ja kolleegid (Koenig jt 2001, 18; Koenig jt 2012) on koostanud mitu käsiraamatut, kus metaanalüüside ja uurimistööde kokkuvõtetes tuuakse välja ohtralt tõendeid spirituaalsuse kasutamise tõhususest kliinilises töös ning tervishoius. Spirituaalsus on oluline psühhoneuro-immunoloogiline kaitsetegur ka füüsilise tervise näitajate puhul (vt joonis 3).



Joonis 3. Spirituaalsus psühhoneuroimmunoloogilise kaitsefaktorina. Kohandatud professor Harold G. Koenigi jooniste järgi (Koenig 2008).

Üks peamisi verstaaposte spirituaalsuse lõimimisel vaimsele tervisele ja taastumisele suunatud mudelitesse on 1999. aastal USAs avaldatud nn *Suregon General* rahvatervise raportis (*Mental Health ...* 1999). Raporti koostajad, tuntud vaimse tervise spetsialistid nimetavad taastumise tõhusate komponentidena mitmel korral klientide personaalseid uskumusi, spirituaalsust ja religiooni, mis pakuvad inimesele tuge ja tähendust, et tulla toime haiguste, leina ja muude kannatustega.

Hea näitena sobib siia ka vahest tuntuim spirituaalsusega seotud taastumisvõimalus, mis on kasutusel just seoses sõltlastega ehk AA (anonüümsed alkohoolikud) ning 12 sammu programm, mis tunnistab transtsendentseid väärtusi, kuid ei ole seotud kindla religiooniga ning suunab inimese oma probleemi teadvustamisele.¹¹ Iseenesest mõistatavana tundub spirituaalse ja religioosse temaatika tõstatumine ja kasutamine palliatiiv- ehk valuravis, kus koolitusvajaduse, spetsiifiliste teadmiste ja oskuste olulisust on uuritud üle-euroopaliselt (Paal jt 2015).

Spirituaalne toetus

Kliendi spirituaalsuse võimalustele tähelepanu pööramine ja nende kasutamine kliendi toetamiseks eeldab spetsialistilt vastavaid teadmisi ja hoiakuid. Ideaalis saavad inimesele pakkuda toetust spirituaalsusega seotud teemade puhul nii vaimse tervise spetsialistid, sotsiaaltöötajad, ja miks mitte ka lähivõrgustik. Igal juhul tuleks hoiduda halvustamisest ja tõrjuvast hoiakust, kui inimene tunneb huvi religiooni või spirituaalsusega seotud teemade vastu, mõtestab vastavalt sellele oma elu ja tervisega seotud küsimusi ja tahab spirituaalsusega

seotud teemadel rääkida. Ainult hirmust ja alaväärsustundest vaba inimene on võimeline arenema ja taastuma. Kui spetsialist ei tunne ennast kindlana spirituaalsusega seotud teemade suhtes, siis saab siin abiks olla hingehoidja kaasamine meeskonda või personali koolitamine nendel teemadel. Spirituaalne toetus hõlmab valmisolekut ja oskust inimest kuulata, spirituaalsusega seotud teemadel kaasa rääkida ja inimest selle käigus suunata, oskust hinnata inimese vajadusi, võimaluste loomist osavõtuks meelepärares, inimese spirituaalsust toetavates tegevustes.

Nõustajad ja tugiisikud peaksid oskama vahet teha spirituaalsetel kriisidel ja psühhopaatoloogial ilmingutel, et ühest küljest haigusi mitte romantiseerida ning samas märkamata jätta spirituaalset kriisi kui inimese spetsiifilist distressi (Cooke 2014).

Samuti tuleks arvestada, et mõnikord võivad kliendid ja spetsialistid näha spirituaalsuse rolli taastumises üsnagi erinevalt. Nii selgus 2016. aastal skisofreeniaga patsientide ja tervishoiutöötajate hulgas korraldatud uuringust (Ho jt 2016), et patsiendid keskendusid eelkõige stabiilsusele, rahule ja kasvule ning vähem eksistentsiaalsetele küsimustele, seevastu personal nägi spirituaalsuse rolli rohkem sümptomite leevendamise, sotsiaalse aktsepteerimise ja haigusega toimetuleku vaatenurgast. See näitab, et enne spirituaalsuse hindamist ja spirituaalse toetuse kavandamist tuleks jõuda ühisele arusaamisele, miks on spirituaalsuse kaasamine taastumisse tähtis.

On mitmeid viise, kuidas ühendada spirituaalseid ja religioosseid teemasid rehabilitatsiooniprogrammidega, mis on mõeldud eelkõige psüühikahäiretega inimestele.

¹¹ Anonüümsed Alkohoolikud; 12 sammu programm: <http://aestonia.com/mis-aa-12-sammu>.

Fallot (2001) nimetab oma artiklis nelja võimalust, mis on suures osas rakendatavad:

- 1) muuta spirituaalsuse hindamine teenuse planeerimisel selle tavapäraseks osaks
- 2) korraldada spirituaalsetele ja religioossetele probleemidele suunatud grupid (vestlusringe)
- 3) siduda spirituaalsus psühhoterapia eri suundadega
- 4) hõlbustada suhteid spirituaalset tuge pakkuvate kogukondadega.

Järgnevalt kirjeldan lühidalt spirituaalsuse hindamist ja mõningaid teisi praktilisi võimalusi spirituaalse toetuse pakkumiseks rehabilitatsioonis ja taastumisprotsessis. Ka siis, kui sotsiaaltöötaja või tegevusjuhendaja ei hakka ise hindamist läbi viima, võib toodud küsimustest olla abi mõistmaks, milliseid valdkondi või teemasid võib spirituaalsusega seotud vestluses puudutada.

Spirituaalsuse hindamine

Spirituaalsuse hindamise käigus kogutakse andmeid inimese spirituaalsusega seotud kogemustest, uskumustest ja eesmärkidest, analüüsitakse ja sünteesitakse neid ning kavandatakse selle põhjal tegevusi, mida saab lülitada tegevuskavadesse, rehabilitatsiooniprogrammidesse või raviplaanidesse. Spirituaalsuse hindamine ei ole kindlasti lihtne ülesanne, kuid mitmed valdkonna spetsialistid tõdevad, et juba põgus inimese spirituaalse ajaloo kohta andmete kogumine ja sellele tähelepanu pööramine klientidega vesteldes on suur samm, mis aitab täiendada igakülget rehabiliteerimist.

Tegeledes psüühiliste erivajadustega inimestega, peab kindlasti selgeks tegema, kuidas individuaalsed spirituaalsed vajadused on seotud indiviidi diagnoosiga: kuidas need mõjutavad tema haiguse kulgu, kas nad on toetavad ja taastumisele suunatud

või seotud psühhootiliste ilmingutega. Samas võivad spirituaalsusega seotud teemad nagu eesmärgid, tähendused, usk ja lootus anda spetsialistidele informatsiooni selle kohta, kuidas inimene tuleb toime, elades koos oma haigusega, ning samuti selle kohta, kuidas haigus paneb proovile inimese väärtuste ja isiklike uskumuste süsteemi. (Culliford ja Eager 2009).

Spirituaalsuse hindamine on üks paremaid viise integreerida spirituaalsusega seotud teemad vaimse tervise valdkonnaga (Mental Health Foundation 2006). Spirituaalsuse hindamine viitab inimese religioossete või spirituaalsete uskumuste ja praktikate sisu ja funktsioonide mõistmisele. Selleks on loodud mitmeid mudeleid. Roger Fallott (2001) toob George Fitchettile toetudes (1993) välja hindamise meetodid seitsmes kategoorias: *uskumus* (kuidas inimesel areneb eesmärgi ja tähenduse tajus); *kutsumus ja tagajärjed* (kuidas inimene mõistab oma kohustusi ja nende täitmise/mitteräitmise tulemusi); *kogemus ja emotsioon* (inimese spirituaalse elu afektiivne külg); *julgus ja kasvamine* (kuidas inimene seisab silmitsi muutuste ja kahtlustega); *rituaalid ja toimingud, praktika* (kuidas inimene väljendab võtmeuskumusi); *kogukond* (kuidas inimene osaleb formaalsetes või mitteametlikes gruppides ja jagab oma praktikat); *autoriteet ja juhtimine* (mis enim mõjutab inimese tuumuskumusi). Selline lähenemine keskendub pigem uskumuste funktsioonidele kui nende sisule, seetõttu on seda sobiv kasutada just neis piirkondades, kus inimestel on mitmekesiseid religioosseid kogemusi ja esineb kultuuride ristumist. Selline lähenemine spirituaalsusele on teadlikult lai ja kõikehõlmav. Kuna see eeldab, et iga inimese elus on spirituaalne mõõde, siis võib seda kasutada abistavalt vaatamata sellele,

kas vastaja identifitseerib end religioosse või spirituaalse inimesena või mitte.

Fallot (2001) kirjeldab oma artiklis mõnevõrra lihtsustatud versiooni Fitchetti käsitlest, mis on kohandatud töötamiseks just raskekujuliste psüühikahäiretega inimestega. See koosneb neljast sammust. Esiteks toimub avatud vestlus, mille tulemusena intervjuerijal tekib arusaam inimese neljast spirituaalsest valdkonnast: uskumused ja tähendus; kogemus ja emotsioon; rituaalid ja toimingud ning kogukond. Teiseks intervjuerija hindab, kui selgesõnaliselt kasutab klient kindla religiooniga seotud väljendeid, rääkides oma kogemustest igas valdkonnas. Kolmandaks hinnatakse, millist rolli mängib iga valdkonna kogemus inimese üldises heaolus (kas selle roll taastumises on positiivne või negatiivne). Neljandaks arutab intervjuerija kogutud informatsiooni põhjal kliendiga, kas ja kuidas spirituaalsed küsimused peaksid sisalduma teenuse plaanis – kas osana kliendi ressurssidest, probleemidest või eesmärkidest.

Hindamise tarvis on koostatud ka mitmeid teste ning küsimustikke. Laias laastus võib hindamist jagada väga lühikeseks (*screening*), lühikeseks (*spiritual history taking*), ja mahukaks (*spiritual assesment*). Kliendi/patsiendi spirituaalse ajaloo kogumiseks sobib hästi näiteks Puchalski (Puchalski ja Romer 2000) arendatud FICA¹² meetod, mida siin kohandatult esitan:

F – Faith and Belief (usk ja uskumine): Kas sa pead ennast spirituaalseks või religioosseks inimeseks? Kas sul on usuga seotud aspekte, mis aitavad sul toime tulla stressi või

haigusega? Mis annab su elule tähenduse?

I – Importance (usu tähtsus): Kui suurt tähtsust omab usk sinu elus ning kas sinu usk mõjutab sinu toimetulekut elades koos haigusega või erivajadusega?

C – Community (kogukond): Kas oled mõne religioosse või spirituaalse kogukonna liige? Kui jah, siis kas ja kuidas nad sind toetavad?

A – Address in Care (rakendus): Kas sa soovid, et me käsitleme neid teemasid sinu raviplaanis (tegevuskavades, rehabilitatsiooniprogrammides jne?)

Mitmed eksperdid (Koenig ja Pritchett 1998, Koenig 2004, Culliford 2007) on oma töödes rõhutanud klientide ja patsientide nn spirituaalse ajaloo või anamneesi koostamise olulisust. Selle käigu võib esitada niisuguseid küsimusi nagu: kas religioon ja usk on Teie elus oluline? Kuidas on usk mõjutanud Teie elu minevikus ja käesoleval ajal? Kas Te olete spirituaalse või religioosse kogukonna liige? Kas Teil on mõni spirituaalne vajadus, millega soovite minu poole pöörduda? Isegi põgus tähelepanu nendele küsimustele avab spetsialistile olulise perspektiivi, et rikastada kavandatud teenuseid. Nende küsimuste esitamiseks ei pea tingimata olema hingehoidja või haigla kaplan. Kuigi selle suhtes on ka kriitilisi hoiakuid, sest spirituaalse ajaloo kogumine on siiski keeruline ja vastutusrikas ülesanne, mis eeldab mitmeid oskusi, hoiakuid ja isiksuseomadusi nagu „teise inimese jaoks olemas olemine”, „mitte ainult kuulmine, vaid kuulamine”, „sõnumi mõistmine ridade vahelt” jpm. (Paal jt 2017).

¹² <https://smhs.gwu.edu/gwish/clinical/fica>.

Kogukonnad spirituaalse ja religioosse toe pakujana

Kui spirituaalsest mõttest saame eeskätt kõneleda kui sisemisest ja individuaalsest ressursist, siis välimise ehk keskkondliku ressursina ja tugevusena võib esile tuua kogudused või spirituaalseid väärtusi aktiveerivad kogukonnad. Eestiski on palju näiteid religioosse taustaga ühendustest, kes võtavad aktiivselt osa praktilisest sotsiaaltööst, nt Samaaria Eesti Misjon, Abikeskus Šalom, Lootuse Küla jt. Religioossetes organisatsioonides on sageli väga vähe stigmatiseerimist psüühikahäirete suhtes. Samas ei pruugi mõned religioosset ühingud mõista psüühikahäirete spetsiifikat, haiguste komorbiidsust ja kaksikdiagnoosi (sõltuvushäirete ja psüühikahäirete koos esinemine). See on vaimse tervise spetsialistidele suur väljakutse. Spetsialistide ja religioossete gruppide poolt kliendile antavate soovitude vastuolulisus võib jätta kliendi piinarikka dilemma kätte, kus ühe autoriteedi juhiseid järgides ohustab see suhet teisega,¹³ seda nii vaimupuueteega kui psüühikahäiretega klientide puhul. Koostöö vaimse tervise spetsialistide ja koguduste vahel aitab kaasa kliendi huvides tegutseva võrgustiku kujunemisele, mis väärtustab indiviidi isiklikke uskumusi ning aitab kaasa igakülgsel taastumisele psüühikahäiretest ja toimetuleku tõhustumisele. Haiguste ägenemise korral on sellisel juhul võimalik operatiivselt infot vahetada, mis aitab kliendil vajadusel pöörduda õigeaegselt haiglasse ravile. On oluline, et rehabilitatsioonimeeskonnal oleks ülevaade oma piirkonna religioossetest ja spirituaalsetest organisatsioonidest. Lisaks tuleks arvestada klientidega, kes soovivad astuda mõne koguduse liikmeks. Siinkohal võib abi olla spirituaalsuse hindamisel saadud infost ning kohalike võimaluste tundmisest, mille põhjal teenuseosutaja

saab kujundada plaani leidmaks kliendi spirituaalsetele ja vaimse tervise vajadustele vastav kogudus või kogukond. Selle alla kuuluvad nii traditsioonilised kristlikud, budistlikud jmt kogudused kui ka näiteks jooga või vabastava hingamise stuudiod, meditatsiooniharjutusi praktiseerivad kogukonnad, võitluskunstiklubid ja rituaalsed tantsutrennid.

Spirituaalsed kogukonnad ja kogudused pakuvad ühtekuuluvustunnet, aitavad hoida alal jagatud tähendusi; leevendada stressi; pakuvad rasketel aegadel nii kägatsutavat kui ka emotsionaalset tuge, tutvustavad ja õpetavad toiminguid ning rituaale, mis struktureerivad inimese elu ja annavad elule mõtte.

Toetust pakuv spirituaalne praktika

Läbi sajandite on inimesed oma kannatustele, probleemidele ning muredele otsinud leevendust nii loitsudest, rituaalidest kui palvetest. On kultuure ja kohti, kus jätkuvalt tegeldakse traditsiooniliste harjutustega nagu kontemplatsioon¹⁴, palve, meditatsioon ja erinevad jooga koolkonnad. Samas on lääne teaduslik psühholoogia järjest enam pilku pööramas ida poole ning mitmeid ida tehnikaid on kaasatud ja segatud moodsate teraapiatega. Näiteks on religiooni ja spirituaalsust integreeritud kognitiiv-käitumuslikku teraapiasse (Pearce jt 2015, Good 2010), on kasutatud mindfulnessi ehk teadveloleku äratamise tehnikaid (*Mindfulness s.a.*, *Mindfulness: Finding... s.a.*, McDonough 2007), aikidod jt (*Aiki Extensions s.a.*).¹⁵

Võitluskunstides rakendatakse hävitamiseks mõeldud praktika tööle enesearengu eesmärgil. Oluline on rahutu meele allutamine võitlust õppides, et mitte kunagi võidelda. *Bu-jutsu* ehk sõjakunst muutub

individuaalsel tasandil *budo*'ks ehk võitluskunsti teeks (*do*) – sama sõnajuur, mis *taoismis*, tähendab kulgemist. Ameerikas on kasutatud psühhoterapias aikidod, mida praktiseerib ka üks maailma tuntumatest spirituaalsete kriisidega tegelevatest psühholoogidest David Lukoff (Faggianelli ja Lukoff 2006).

Ka palvel ja meditatsioonil on rehabilitatsioonis palju kasutamisevõimalusi. Ann Cotter ja tema kolleegid (Cotter jt 2003) nimetavad palvel ja meditatsiooni ühe mündi kaheks pooleks, kus palve on pigem aktiivne pool kontakti võtmiseks kõrgemate jõududega ning meditatsioon kujutab endast kuulavat poolt. Selles kontekstis on meditatsiooni eesmärk vähendada väliste stiimulite tähtsust ja teisalt kasvatada sisemise tarkuse osakaalu. Piltlikult öeldes tähendab see võtta aeg maha ja keskenduda sellele, mida sisemiselt tahetakse, vajatakse, soovitakse ning eristada need vajadused välise materiaalse maailma poolt peale surutud infost. Mantrate¹⁶ lugemine on tõhus, selleks et tühjendada aju, mis sageli võib olla liigselt keskendunud oma haigusele. Selliseid tehnikaid on võimalik taastumisteel olevatele erivajadustega inimestele õpetada.¹⁷

Klientidele spirituaalse toe pakkumise võimalusi

Spirituaalsust lahates näeme, et tegemist on kontseptsiooniga, millel on erinevaid tahke

ja komponente ning tervikuna hõlmab see kogu elukorraldust. Näiteks kultuuriline mõõde (muusika, kirjandus, tants); psühholoogiline mõõde (tähendus, elu mõte, tahe ja motivatsioon, tunded, lein ja kaotusvalu); sotsiaalne mõõde (kogudused, seotus, väärtused); tervisega seonduv (heaolu, toimetulek, valude puudumine) jne. Sarnaselt taastumisteooriaga, ei puuduta spirituaalsus inimese haigust, vaid on seotud inimese ja tema eluga. Keskendutakse tugevustele, mitte patogeneesile.

Järgnevalt on erinevatele autoritele tuginedes koostatud ülevaade mõnedest tehnikatest ning soovitustest spirituaalse toe pakkumise võimalustest ja spirituaalsuse rakendamisest klienditöös (Lukoff 2007, Pargament 2007, Culliford ja Eagger 2009, Cooke 2014, Barber jt 2009, 2015). Kui leidub kliente, kes tahavad spirituaalseid ja inimeseluga küsimusi enda jaoks lahti mõtestada, siis järgnevast loetelust leiab tegevusi ja teemasid, kust edasi minna. Kõigi võimaluste kasutamine peab muidugi olema kooskõlas spetsialisti isiklike ja asutuses kokku lepitud põhimõtetega.

Spirituaalsusest teadlikkuse tõstmiseks saab korraldada *vestlusringe* ja *individuaalvestlusi*, samuti soovitada kliendile *taastumiskursusi* ja *kogemusnõustamise koolitusi*. Taastumine võib olla kui spirituaalne teekond võimaliku positiivse tulemusega. Individuaalses või grupivestluses võib käsitleda näiteks järgmisi küsimusi. Mis annab

¹³ Autori praktikas oli juhtum, kus kogudus keelas sotsiaalteenusel oleval kliendil osa võtta joogatundidest teenusepakkuja juures. Teisel juhul arvas usukogudus oma liikmete hulgast välja psüühikahäirega kliendi, kes ei suutnud suitsetamist ja kohvijoomist maha jätta, kuigi oma südames soovis ta olla koguduse liige.

¹⁴ Religioossed sisevaatluslikud mõlustehnikad.

¹⁵ Isiklikust praktikast tean mitut krooniliste haigustega (skleroosis multipleks, artriit jt) inimest, kes tänu võitluskunstidele on hoidnud oma keha toonuses; samuti on lihtne ja tõhus tehnika „5 tiibetlaste harjutused“ https://en.wikipedia.org/wiki/Five_Tibetan_Rites.

sulle elus jõudu ja väge? Kas oled mõelnud, millisena sa näed oma elu viie või kümne aasta pärast? Kuhu sa teel oled? Vajadusel võib kaasata külalislektoriteks eri koguduste juhte, spirituaalsete praktikatega tegelejaid ja õppejõude. Grupitöö positiivseks tulemuseks on näiteks see, et liikmed seostavad enda uskumusi oma eluolukorraga ning avastavad, et vaatamata religioonide paljususele on tähenduse ja eesmärgi otsingud kõigil inimestel ühised. Arutelu spirituaalsusest toob selgust enda ja teiste uskumuste rollist elus.

Võimaluste loomine spirituaalsust toetavate praktikatega tegelemiseks. Kui kliendil on kindlad usulised veendumused või huvi spirituaalsete praktikate vastu, mis toetavad tema taastumist, siis saab klienti selles julgustada ning luua võimalusi nende praktiseerimiseks. Näiteks saab luua klientidele *võimalusi palvetamiseks või mediteerimiseks ja teisteks usulisteks toiminguteks; jagada infot ja võimaldada kliendil osaleda koguduse või spirituaalse kogukonna tegevuses*, mis on kooskõlas kliendi kogemuste ja väärtustega. (See eeldab koguduse ja rehabilitatsioonispetsialistide head koostööd, mitte konkurentsi kliendi pärast.) Kui klient on leidnud endale sobiva *spirituaalse praktika* (nt võitluskunstid, palve, meditatsioon, kontemplatsioon, tants, jooga harjutused, 5 tiibetlast vmt), võib tegevusjuhendaja õhutada klienti sellega tegelema. Vajadusel võib juhendaja minna kursustele kaasa või kutsuda õpetajaid, treenereid, juhendajaid kliendipäevadele ning

ühisüritustele. Mõnikord võib see sisaldada ka koos praktiseerimist. Klientidele võib soovitada *vaimset kirjandust*, mis kindlasti eeldab valdkonna tundmist, kuid kaasata saab ka biblioteraapia spetsialiste või autoreid, kelle käsitletud teemaderingi vastu on tekkinud huvi.

Nõustamine ja psühhoteraapia. Spirituaalsusega seotud küsimustes nõustamiseks ja kriiside ületamiseks tuleks kaasata meeskonda hingehoidjaid või eksistentsiaalsete, religioossete, spirituaalsete teemadega tegelevaid psühhoterapeute (logoteraapia, analüütiline teraapia, transpersonaalne psühhoteraapia jmt). *Nõustamine ja vestlused hingehoidja või terapeudiga* võivad aidata klientidel leida vastuseid eksistentsiaalsele, st elu tähendusele, eesmärgile ning mõttekusele suunatud küsimustele.

Spetsialistide teadmised ja hoiakud. Enda kurssi viimiseks spirituaalsusega seotud teemadega on juhendajal soovitatav alustuseks tutvuda mõne brošüüri või ülevaateartikliga. Näiteks Briti Kuninglik Psühhiaatriite Kollegium on välja andnud voldiku „Spirituality and Mental Health” (*s.a*) ja käsiraamatu spirituaalsest hoolest (*care*) (Barber jt 2009; 2015). Teadvustada tuleks ka isiklikke spirituaalsusega seotud hoiakuid ja kogemusi ning seda, kuidas need mõjutavad suhtlemist kliendiga. Spirituaalsustundlikku sotsiaaltööd (*spiritually sensitive social work*) uurinud Edward R. Canda (1999, 2002) toonitab, et igal spetsialistil on oluline teadvustada ka omaenda isiklikku spirituaalsust, mis

¹⁶ Mantra on silp, sõna, lause või heli, mida kasutatakse teadvus seisundi muutmiseks või suunamiseks. Tuntuim mantra on budismis OM „*om mani padme hum*” või kristaniitide „*Hare Krišna*” jt.

¹⁷ Näiteks töötab samal printsiibil SA Pärnu Haigla Psühhiaatrikliiniku Päevakeskuses populaarne lõõgastusring grupimeditatsioonina (tegevusjuhendaja Ülle), samuti on nädala kavas kundalini jooga (tegevusjuhendaja Liis).

võib liigse tehnokraatia tingimustes kergesti ununeda. Igal juhul tuleks klienti kohelda austuse ja taktitundega, kui ta soovib vestelda spirituaalsusega seotud teemadel või kui ta ennast avab. Vältida tuleks keerulist religioosset sõnavara. Kui tunned, et jääd hätta, tuleks pigem vestlus lõpetada ja aidata leida spetsialist, kellel on oskusi ja pädevust spirituaalsuse ja religiooni teemade käsitlemiseks.

Kokkuvõtteks

Paljude riikide ja vaimse tervise spetsialistide kogemus kinnitab, et spirituaalsuse integreerimine klientide taastumisse võib olla tulemuslik, kuna see aitab inimestel parandada enesekontrolli, suurendada oma isiklikku võimekust, tugevdada suhteid, tõsta enesehinnangut ja enesekindlust, tulla toime kriisidega ning taastada meelerahu. Spirituaalsuse teadvustamine taastumise teekonnal aitab luua uut identiteeti, leida elucesmärgi ja tähenduse.

Eesti (eri)hoolekande- ja rehabilitatsiooniasutustes ei ole klientidele siiani pakutud spirituaalset tuge, mis olnuks süsteemne ja integreeritud teiste teenustega. On küll kaasatud hingehoidjaid mõnda võrgustikku või töötavad nad mõnes hooldushaiglas, kuid laiemalt pole hoolekandes spirituaalse toe võimalusi rakendatud. Nagu artiklis antud põgusast ülevaatest nähtub, on spirituaalne toetus laiem kui kaplani või hingehoidja töö.

Seda saaksid pärast täiendusõpet pakkuda mitmed avatud mõtlemisega hoolekande ja rehabilitatsiooni valdkonna spetsialistid, kes on ära tabanud kasutamata ressursi inimese mitmetahulises loomuses. On lihtsaid meetodeid, mille abil inimese spirituaalseid vajadusi hinnata ning teda selle põhjal toetada. Olles kaasteeliseks koos kliendi ja tema looga ja aidates inimesel orienteeruda inimelu tähendusele ja mõtestatusele, saab vältida tagasilangusi ja oma haavatavusega tulla toime.

Autoril on plaanis koos teemast huvitatud kolleegidega selle teemaga edasi tegelda: viia läbi uurimusi, tõlkida eesti keelde ja valideerida nii teste kui skaalasid spirituaalsuse hindamiseks ja küsitlusteks, avaldada infomaterjale ning erialast kirjandust personalile. Eesti haiglates korraldatud pilootuuringust „Tervisevaldkonna spetsialistide arvamused ning kogemused spirituaalsuse, hingehoiu ja meditsiinilise pluralismi teemadel” (Uibu, Meel, Linnuste 2016) selgus, et Eesti tervishoiuspetsialistid tunnevad huvi täienduskoolituste vastu, mis annaks üldist infot religiooni ja spirituaalsusega seotud teemadel. Usun, et selliseid koolitusi võiks pakkuda ka sotsiaalvaldkonna töötajatele. Loodan, et artiklis käsitletu aitab sotsiaalvaldkonna spetsialistidel teadvustada võimalusi, kuidas kaasata inimese spirituaalsust klienditöösse ning äratav huvi sellele teemale edasise uurimise vastu. **S**

¹⁸ Logoterapia on eksistentsiaalse psühhoterapia liik, mis põhineb elu tähenduse ja seismise mõtte otsingul. Logoterapia rajaja oli Austria psühhiaater Viktor Frankl.

¹⁹ Analüütiline teraapia baseerub Carl Gustav Jungi analüütilise psühholoogia tehnikatel. Eesti Analüütilise Psühholoogia Selts <http://junganalys.ee/>.

²⁰ Transpersonaalne psühholoogia uurib transpersonaalseid läbielamisi, muutunud teadvuseseisundeid ja religioosseid kogemusi, ühendades nüüdisaegsed psühholoogilised kontseptsioonid, teooriad ja meetodid lääne ja ida traditsiooniliste vaimsete praktikatega www.transpersonaalne.ee.

Viidatud allikad

- Aiki Extensions.** Harmony in Action. www.aikiextensions.org/programs/working-groups/psychotherapy/ (28.12.2016).
- Altnurme, L.** (2013). Uus vaimsus – mis see on? Mitut usku Eesti III. Valik usundiloolisi uurimusi: uue vaimsuse eri. Tartu Ülikool.
- Barber, J., Parkes, M., Wilson, C.** (2009, 2015). Handbook of spiritual care in mental illness. Birmingham and Solihull: Mental Health NHS Foundation Trust. www.rcpsych.ac.uk/pdf/Handbookofspiritualcareinmentalillness.pdf (28.12.2016).
- Canda, E. R.** (1999). Spiritually Sensitive Social Work: Key Concepts and Ideals. *Journal of Social Work, Theory and Practice*. Bemidji State University and Inter-University Centre. www.bemidjistate.edu/academics/publications/social_work_journal/issue01/pdf/canda.pdf (18.12.2016).
- Canda, E. R.** (2002). A World Wide View on Spirituality and Social Work: Reflections from the USA Experience and Suggestions for Internationalization. *Currents: New Scholarship in the Human Services*, vol.1, University of Calgary Press, 1–6. www.ucalgary.ca/currents/files/currents/v1n1_canda1.pdf (07.02.2006).
- CARE metoodika juhend.** www.epry.ee/care-eesti/ (22.04.2017).
- Contemplative mind in life.** (2014). <https://contemplativemind.wordpress.com/peer-reviewed-research-mindfulness-meditation-contemplative-practice/> (12.03.2017).
- Cooke, H.** (2014). Spiritual Crisis, Emergence, and Mental Health. Presentation for: Rethinking Psychiatry. www.rethinkingpsychiatry.org/wp-content/uploads/2015/01/Spiritual-Crisis-Emergence-and-Mental-Health.pdf (28.12.2016).
- Cotter, A. C., Spangenberg, V., Mulford, G., Wilcox, J.** (2003). Prayer, Meditation, and Spirituality in Rehabilitation. Teoses: Wainapel, S. F., Fast, A. (toim.). *Alternative Medicine and Rehabilitation*. Demos Medical Publishing: New York, 185–196. www.demosmedical.com/media/wysiwyg/pdf/Wainapel_08.pdf (28.12.2016).
- Culliford, L.** (2002). Spiritual care and psychiatric treatment: an introduction. *Advances in Psychiatric Treatment*, 8, 249–258. www.psychologytoday.com/sites/default/files/attachments/52072/apt-2002-spirituality-introduction.pdf (14.06.2016).
- Culliford, L.** (2007). Taking a spiritual history. *Advances in Psychiatric Treatment*, vol. 13, 212–219.
- Culliford, L.** (2016). Spiritual Leadership. *Psychology Today*. www.psychologytoday.com/blog/spiritual-wisdom-secular-times/201610/spiritual-leadership (28.12.2016).
- Culliford, L., Eagger, S.** (2009). Chapter 2. Assessing spiritual needs. Teoses: Cook, C., Powell, A., Sims, A. (toim.). *Spirituality and Psychiatry*. RCPsych Publications, 16–39.
- Drake, R., Whitley, R.** (2014). Recovery and Severe Mental Illness: Description and Analysis. *The Canadian Journal of Psychiatry*, 59, 236–242.
- Faggianelli, P., Lukoff, D.** (2006). Aikido and Psychotherapy: A Study of Psychotherapists Who Are Aikido Practitioners. *Journal of Transpersonal Psychology*, July 1. Vol. 38, No. 2, 159–178.
- Fallot, R. D.** (2001). Spirituality and religion in psychiatric rehabilitation and recovery from mental illness. *International Review of Psychiatry*, 13, 110–116.
- Fitchett, G.** (1993). *Assessing spiritual needs: a guide for caregivers*. Minneapolis, MN: Augsburg.
- Good, J. J.** (2010). Integration of Spirituality and Cognitive-behavioral Therapy for the Treatment of Depression. *Philadelphia College of Osteopathic Medicine, Psychology Dissertations*. Paper 55. http://digitalcommons.pcom.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=psychology_dissertations (28.12.2016).
- Hay, D., Hunt, K.** (2000). Understanding the Spirituality of People Who Don't go to Church. A report on the findings of the Adults' Spirituality Project at the University of Nottingham. Mission Theological Advisory Group.
- Hietala-Paalasmaa, O., Narumo, R., Yrttiaho, K.** (toim.). (2006). Kuntoutuja, ammattilainen, vertainen. Mielenterveyskuntoutuksen kolme asiantuntijaa TRIO-projekti arviointi- ja loppuraportti. Mielenterveyden keskusliitto ry. http://mtkl.fi/wp-content/uploads/2014/04/Trio_raportti2007.pdf (14.04.2016).
- Ho, R. T. H., Chan, C. K. P., Lo, Ph. H. Y., Wong, P. H., Leung, P. P. Y., Chen, E. Y. H.** (2016). Understandings of Spirituality and Its Role in Illness Recovery in Persons with Schizophrenia and Mental-Health Professionals: A Qualitative Study. *BMC Psychiatry* 16, 86. <https://bmcpsy psychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-016-0796-7> (08.05.2018).

- Klein, C. Altmeyer, S.** (2016). „Spirituality” and „Religion” Corpus Analysis of Subjective Definitions in the Questionnaire. Teoses: Streib, H., Hood, R.W. jr. (toim). *Semantics and Psychology of Spirituality: A Cross-Cultural Analysis*, 105–125.
- Koenig, H. G.** (2004). Taking a spiritual history. *Journal of the American Medical Association*, 291, 2881.
- Koenig, H. G.** (2008). Concerns About Measuring „Spirituality” in Research. *The Journal of Nervous and Mental Disease*, Vol. 196 (5).
- Koenig, H. G., King, D, Carson, V. B.** (2012). *Handbook of religion and health*. 2nd ed. Oxford University Press.
- Koenig, H. G., McCullough, M. E., Larson, D. B.** (2001). *Handbook of religion and health*. Oxford University Press.
- Koenig, H. G., Pritchett, J.** (1998). Religion and psychotherapy. Teoses: Koenig, H. G. (toim.), *Handbook of religion and mental health*. San Diego, CA: Academic Press, 323–336.
- Linnuste, I., Meel, L., Uibu, M.** (2016). Tervisevaldkonna spetsialistide arvamused ning kogemused spirituaalsuse, hingeoiu ja meditsiinilise pluralismi teemadel. Avaldamata pilootuuring.
- Lukoff, D.** (2007). Spirituality in the Recovery from Persistent Mental Disorders. Special Section: Spirituality/Medicine Interface Project. *Southern Medical Journal*, 100, 642–646. www.spiritualcompetency.com/pdfs/smjrecovery2007.pdf (28.12.2016).
- McDonough, V. T.** (2007). The Role of Mindfulness, Meditation, and Prayer After Brain Injury. Teoses: Williams, M., Teasdale, J., Segal, Z., Kabat-Zinn, J. (toim.) *The Mindful Way Through Depression*. New York: Guilford Press. www.brainline.org/content/2009/12/the-role-of-mindfulness-meditation-and-prayer-after-brain-injury_pageall.html (20.12.2016).
- The Mental Health Foundation** (2006). The impact of spirituality upon mental health www.mentalhealth.org.uk/sites/default/files/impact-spirituality.pdf (23.04.2018).
- Mental Health: A Report of the Surgeon General.** (1999). Bethesda, Surgeon General. <https://profiles.nlm.nih.gov/ps/access/NNBBHS.pdf> (20.12.2016).
- Mindfulness.** Wikipedia, the Free Encyclopedia. <https://en.wikipedia.org/wiki/Mindfulness> (28.12.2016).
- Mindfulness: Finding Peace in a Frantic World.** <http://franticworld.com/what-is-mindfulness/> (28.12.2016).
- Paal, P., Leget, C., Goodhead, A.** (2015). Spiritual care education: Results from an EAPC survey. *European Journal of Palliative Care*. 22. 91–95.
- Paal, P. Frick, E., Roser, T., Jobin, G.** (2017) Expert Discussion on Taking a Spiritual History. *Journal of Palliative Care*. Volume: 32 issue: 1, 19–25.
- Pargament, K. L.**, (2007). *Spirituality integrated psychotherapy. Understanding and Addressing the Sacred*. The Guilford Press. New York London.
- Pearce, M. J., Koenig, H. G., Robins, C. J., Nelson, B., Shaw, S. F., Cohen, H. J., King, M. B.** (2015). Religiously Integrated Cognitive Behavioral Therapy: A New Method of Treatment for Major Depression in Patients With Chronic Medical Illness. *Psychotherapy* (Chic). 2015, 52(1), 56–66. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4457450/ (08.05.2018).
- Puchalski, C., Romer L., A.** (2000). Taking a spiritual history allows clinicians to understand patients more fully. *J Pall Med* 2000; 3, 129–137. <https://courses.washington.edu/bh518/Articles/takingaspiritualhistory.pdf> (12.05.2017).
- Saad, M., Medeiros, R.** (2012). Spiritual-Religious Coping – Health Services Empowering Patients’ Resources. Teoses: *Complementary Therapies for the Contemporary Healthcare*. <http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/40016.pdf> (14.12.2016).
- Slade, M.** (2009). The contribution of mental health services to recovery. *Journal of Mental Health*, 18(5), 367–371. doi: 10.3109/09638230903191256 (08.05.2018).
- Sotsiaalministeerium** (2014). Kogemusnõustamise teenus – soovituslik juhend. www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/esmargid_ja_tegevused/Sotsiaaltoetused/Muud_toetused_ja_teenused/kogemusnoustamise_teenuse_juhis.pdf (08.05.2018).
- Spirituality and Mental Health.** The Royal College of Psychiatrists. <https://www.rcpsych.ac.uk/mentalhealthinformation/therapies/spiritualityandmentalhealth.aspx> (08.05.2018).
- Tanyi, R. A.** (2002). Towards clarification of the meaning of spirituality. *Journal of Advanced Nursing*, 39 (5). Blackwell Science Ltd, 500–509. <http://faith-health.org/wordpress/wp-content/uploads/7163977.pdf> (20.12.2016).
- Tsuiman, K.** (2016). Deinstitutionaliseerimine kui kogukonnapõhine teenuste osutamine abivajadusega inimestele. *Sotsiaaltöö* 1, 20–22.

Uibu, M. (2018). Miks ja kuidas kaasata sotsiaalteenuste arendamisel ja analüüsimisel kliente ja teisi olulisi osalisi? *Sotsiaaltöö* 1, 52–56.

WHO global strategy on people-centred and integrated health services (2015). March.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/155004/1/WHO_HIS_SDS_2015.7_eng.pdf?ua=1&ua=1
 (20.12.2016).

Wigglesworth, C. (2014). Spirituaalne intelligentsus: 21 oskust. Tallinn: Tänapäev.

Wilken, J. P., Hollander, D. (2015). Kuidas klientidest saavad kodanikud? Taastumise ja kaasatuse suurendamine CARE metoodika abil. Tallinn: DUO Kirjastus.

Wilken J. P. (2010). *Recovering Care*. Amsterdam: SWP Publishers, 53–61. last edited by Jean Pierre Wilken March (2013) <http://thecareurope.com/?c=recovery&l=en> (08.05.2018).

AUTORIST

Indrek Linnuste (1979) on üle kümne aasta tegelnud psüühikahäiretega inimestega eeskätt SA Pärnu Haiglas. Omab magistrikraadi psühholoogias ja terviseteadustes ning on ennast täiendanud mitmesugustel koolitustel, nagu hingehoid, vanglast vabanenute tugiisik, sõltuvusained jt. Tartu Ülikooli usuteaduskonna religiooni-uuringute doktorantuuris on autori uurimisvaldkonnaks spirituaalsed kriisid ja spirituaalsuse lõimimine tervishoiu- ja rehabilitatsioonisüsteemi. Juhib sotsiaalset ettevõtet OÜ Solve et Coagula, www.secestonia.com, mis pakub kaitstud töötamise teenuseid vähenenud töövõimega inimestele; tegutseb lektori ja koolitajana. Tegeleb ka liikluspsühholoogiaga ning töötab liiklusrikkujatest mootorsõidukijuhtide järelkoolitajana.



Abstract: Spirituality as a resource for recovery and mental health rehabilitation

Indrek Linnuste

PhD student, University of Tartu; mental health practitioner

This article studies spirituality – a dimension connected with the meaning of life, purpose, truth and values – as an insufficiently used resource in the context of practical social work. Due to changes of paradigms in both healthcare and social welfare, the key word of the 21st century psychosocial rehabilitation is user-orientation. In mental health, we can observe an increasing use of recovery models, where users themselves have a leading role. Spirituality as a link between „the bigger picture” and individual self-conception is an essential part of these models. There is significant evidence that the integration of the spiritual resource is effective in models of recovery and mental health rehabilitation services, but it requires appropriate knowledge, skills and attitudes from professionals. Spirituality can be awoken by directing one’s attention to their inner self, but a spiritual approach cannot be taught or forcefully implemented. The article describes different ways of combining spirituality with the rehabilitation process and gives examples of integration: spiritual assessment, cooperation with religious and spiritual communities, various spiritual practices, group work, spiritual care and counseling, etc. Religion and spiritual support offers companionship, relieves stress and helps conquer difficult times by providing a framework to give life structure and meaning. Valuing these resources and evaluating their outcomes provides a new approach to rehabilitation.